

Púrpuras

Paula Juárez González^a y Miguel Turégano-Yedro^{b,*}

^aMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. CS Casar de Cáceres. Cáceres. España.

^bEspecialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS Casar de Cáceres. Cáceres. España.

*Correo electrónico: tureyedro@hotmail.com

Puntos para una lectura rápida

- La púrpura se define como una lesión que no blanquea a la digitopresión y está producida por una alteración de alguno de los componentes hemostáticos: plaquetas, factores de la coagulación o lesiones de la pared vascular.
- Es un síntoma común de muchas patologías, siendo alguna de ellas urgente. Por ello, deben abordarse sistemáticamente y eficientemente.
- A la hora de explorar la lesión purpúrica debemos tener en cuenta si es o no palpable, si es primaria o secundaria, si es localizada o sistémica y el tamaño (petequias si menos de 4 mm, púrpura si entre 5 y 9 mm y equimosis si es mayor a 1 cm).
- La púrpura no palpable más frecuente en nuestras consultas es la producida por plaquetopenia.
- La causa más frecuente de púrpura palpable en las consultas de atención primaria es la vasculitis leucocitoclástica.
- La púrpura leucocitoclástica puede ser secundaria a infecciones, fármacos o a reacciones inmunológicas. La forma de presentación más frecuente se da en la infancia y es la púrpura de Schönlein-Henoch.
- Ante una púrpura leucocitoclástica, debemos vigilar la función renal, ya que condiciona el pronóstico de la enfermedad.

Palabras clave: Púrpura • Vasculitis • Púrpura trombocitopénica inmune • Vasculitis leucocitoclástica.

Relevancia del problema

La púrpura es un motivo de consulta frecuente, en las consultas de atención primaria. Suele ser benigna y su incidencia aumenta exponencialmente con la edad¹. Sin embargo, es un signo clínico que pone de manifiesto numerosas alteraciones, entre las que destacan patologías con afectación sistémica, como coagulación intravascular diseminada, síndrome hemorrágico o vasculitis².

La prevalencia varía en función del síndrome clínico o la entidad responsable. En las consultas de atención primaria, la causa más frecuente de púrpura no palpable es la plaquetopenia, con una prevalencia muy variable que oscila entre el 8,3 y el 67,7% (especialmente en pacientes con patologías críticas), incrementándose también en mayores de 65 años³. Entre el diagnóstico diferencial se incluye la púrpura trombocitopénica inmune, cuya incidencia es de 1-6/100.000 en adultos y 1/10.000 niños, de los cuales el 72% son mujeres de entre 10 y 40 años^{1,4}.

Por otro lado, en atención primaria, la vasculitis leucocitoclástica, supone la primera causa de púrpura palpable¹ y aunque se presenta con mayor frecuencia en niños, afecta a un 10% de la población adulta. En este caso, la incidencia anual en adultos oscila entre 0,8-1,8/100.000 habitantes, siendo más frecuente en hombres, mayores de 65 años y con diabetes⁵.

Definición del problema

La púrpura se describe como lesiones cutáneo-mucosas, de coloración eritematoviolácea que no desaparece a la digitopresión. Se produce como consecuencia de la alteración de alguno de los componentes hemostáticos: plaquetas, factores de la coagulación o lesiones de la pared vascular⁶.

Al inicio del cuadro, las lesiones adquieren coloración eritematosa, evolucionando posteriormente a aspecto purpúrico con tonalidades verdosas y amarillentas⁷, pudiendo finalizar en coloración parduzca².

La púrpura debe diferenciarse del *livedo reticularis*, que se relaciona con isquemia y con entidades sistémicas. Se identifica por una coloración de la piel livedoide (azul, rojo o violáceo) y por presentar morfología reticular⁸.

Clasificación

La clasificación etiológica de las lesiones purpúricas y su posible orientación diagnóstica se detalla en la figura 1.

La clasificación de las púrpuras, según su etiología, se divide en:

A) Púrpuras no palpables: podemos diferenciar en origen cutáneo o sistémico:

A.1) Púrpuras de origen cutáneo:

1. Púrpura de Bateman que, a su vez, se denomina púrpura senil. Se produce por fotoenvejecimiento y atrofia cutánea que empeora debido al uso de fármacos como corticoides, antiagregantes o anticoagulantes⁹.

2. Capilaritis: consiste en lesiones que afectan generalmente a extremidades inferiores. Las lesiones presentan morfología numular, y son de coloración parduzca con petequias en su interior. Se produce por la extravasación de hematíes secundario a un proceso inflamatorio perivascular de etiología desconocida¹.

A.2) Púrpura no palpable de origen sistémico: se deben a alguna de las siguientes alteraciones¹⁰:

1. Alteraciones en la coagulación: factores de coagulación o alteraciones plaquetarias.
2. Alteración de los capilares.
3. Fenómenos tromboticos.
4. Otras causas.

Alteraciones de la coagulación

La principal alteración en la coagulación es la plaquetopenia, que se entiende como la disminución del número de plaquetas, con cifras menores a 140.000 plaquetas/mm³, provocadas por algún trastorno congénito o adquirido^{11,12}.

Púrpura trombocitopénica idiopática (PTI)^{1,4}

Dentro de las alteraciones plaquetarias, se incluye la PTI, un fenómeno autoinmune producido por la destrucción plaquetaria prematura. Si la plaquetopenia es aislada, diremos que es primaria, mientras que si se asocia a enfermedades sistémicas (como lupus eritematoso sistémico, virus de la inmunodeficiencia humana o tumores hematológicos) será secundaria.

Suele ser causa más frecuente de púrpura de larga evolución, no palpable, que afecta a adultos y cuyo diagnóstico suele ser incidental. Puede asociar otros síntomas, como astenia, sangrado de origen digestivo o epistaxis, aunque esto último es más frecuente ante niveles plaquetarios inferiores a 10.000 plaquetas/mm³. En niños son frecuentes antecedentes de infección viral o vacunación 1-3 semanas antes de la aparición de la púrpura^{1,4}.

Trombocitopenia inducida por fármacos

El uso de determinado fármacos y drogas, como la cocaína, es una causa relativamente frecuente de púrpura no palpable de origen sistémico¹³. Se ha asociado a más de 100 fármacos, aunque los más frecuentes se recogen en la tabla 1.

Además de las anteriormente expuestas, cabe destacar aquella inducida por heparina, que aparece con mayor frecuencia en los pacientes tratados con heparina no fraccionada. Se produce una obstrucción vascular como resultado de formación de agregados plaquetarios. El cuadro comienza a

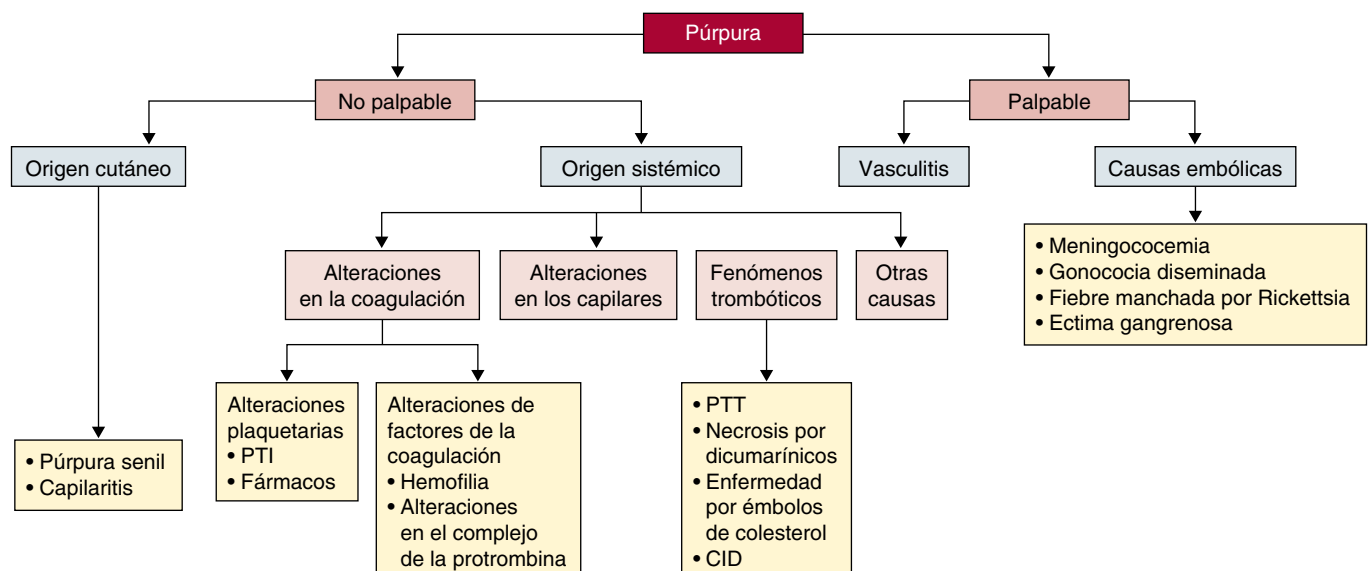


Figura 1. Algoritmo de clasificación etiológica de las lesiones purpúricas. Elaboración propia.

TABLA 1. Fármacos que causan plaquetopenia (ordenado por orden alfabético)				
Abciximab	Antiinflamatorios no esteroideos (AINE)	Cefalosporinas	Cimetidina	Digoxina
Eptifibatida	Famotidina	Furosemida	Ganciclovir	Indinavir
Interferón	Linezolid	Oxaliplatino	Penicilinas	Quinidina
Quinina	Ranitidina	Salicilatos	Sulfamidas	Sulfonilureas
Tirofiban	Trimetoprim-sulfametoxazol	Valaciclovir	Valproato	Vancomicina
Modificada de Curtis ¹¹ .				

la semana del inicio del tratamiento, provocando una plaquetopenia brusca y la aparición de fenómenos trombóticos en la piel y órganos vitales. Las placas necróticas son lesiones características de este cuadro, pudiendo comprometer la vida del paciente². En estos casos, se debe suspender de forma inmediata el fármaco y administrar un anticoagulante alternativo que no produzca reacción cruzada.

Alteraciones en los factores de la coagulación¹⁴

Es el caso de la hemofilia y de alteraciones del complejo de la protrombina. En las hemofilias podemos encontrar manifestaciones hemorrágicas desde el nacimiento. Así, la hemofilia A es el déficit del factor VIII de coagulación, mientras que la hemofilia B es el déficit de factor IX. Clínicamente se caracterizan por la aparición de equimosis y otros sangrados ante mínimos traumatismos. La principal causa de morbilidad es la hemartrosis, aunque también pueden darse otros sangrados a otros niveles, como hematuria o hemorragia digestiva.

Las alteraciones en el complejo de la protrombina, que incluyen los factores II, VII, IX y X, también cursan con púrpura. Estos factores de la coagulación se sintetizan a nivel hepático dependiendo de la vitamina K. Por lo tanto, se verán alterados cuando haya un déficit de vitamina K; por ejemplo, malabsorción intestinal, toma de anticoagulantes de tipo cumarínicos o inmadurez metabólica en el recién nacido (enfermedad hemorrágica del recién nacido).

Alteraciones de la fragilidad capilar

Son situaciones de debilidad en la pared capilar, provocadas por una alteración en la membrana basal. Puede ser consecuencia de alteraciones congénitas, infecciones, déficits vitamínicos o patologías metabólicas. Entre el diagnóstico diferencial hay que señalar entidades como amiloidosis, escorbuto o Ehlers-Danlos¹.

Fenómenos trombóticos

Entre los fenómenos trombóticos encontramos entidades graves, como la coagulación intravascular diseminada (CID), la crioglobulinemia, la púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), la necrosis por dicumarínicos o enfermedad por émbolos de colesterol¹.

Coagulación intravascular diseminada (CID)

Se trata de una activación brusca en la cascada de coagulación debido a diferentes situaciones, como accidentes obstétricos, neoplasias diseminadas, infecciones, accidentes transfusionales o procesos autoinmunes¹⁵. Esta activación de la cascada de coagulación se traduce en el depósito intravascular de fibrina, que condiciona trombosis, isquemia tisular y necrosis, produciéndose un estado de hipocoagulabilidad por la activación secundaria de la fibrinólisis que condiciona una disminución de plaquetas y de otros factores de la coagulación.

La presentación clínica es variada; en los casos más leves se observan petequias y equimosis, mientras que en las formas más graves se desarrollan áreas de necrosis y hemorrágicas. Además, en las formas más graves, pueden desarrollarse hemorragias gastrointestinales y genitourinarias. Analíticamente destaca la trombopenia y el alargamiento del tiempo de protrombina y del tiempo parcial de tromboplastina¹⁵.

Púrpura trombocitopénica trombótica

La PTT es una microangiopatía trombótica que produce anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y disfunción orgánica isquémica, sobre todo a nivel renal y neurológico. Habitualmente tiene una base genética, por mutaciones autosómicas recesivas con niveles de ADAMTS13 menores al 10%. También se describen casos adquiridos, relacionados con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), embarazo o fármacos como clopidogrel^{16,17}.

Necrosis cutánea por dicumarínicos

Esta patología se da principalmente en mujeres y la podemos objetivar en zonas ricas en tejido graso, es decir, en mama, abdomen, glúteos y muslos. Suele ser consecuencia de un probable déficit de factores de coagulación, como las proteínas C y S. Aparece durante los primeros 10 días del uso de dicumarínicos y se manifiesta como un eritema doloroso que evoluciona a placas purpúricas y posteriormente a úlceras necróticas¹⁸.

Enfermedad por émbolos de colesterol

Esta enfermedad afecta mayoritariamente a pacientes con enfermedad aterosclerótica en miembros inferiores. Aparece

TABLA 2. Clasificación de vasculitis en función del tamaño del vaso y los síntomas más comunes de cada subtipo

Vasculitis de vaso grande	• Claudicación de las extremidades • Ausencia de pulsos periféricos • Soplos vasculares • Asimetría de presión arterial • Dilatación aórtica
Vasculitis de vaso mediano	• Nódulos cutáneos • Úlceras • Livedo reticularis • Gangrena digital • Polineuropatía • Presencia de microaneurismas
Vasculitis de vaso pequeño	• Hemorragia alveolar • Manifestaciones oftalmológicas (epiescleritis, uveítis o escleritis) • Glomerulonefritis
Modificada de Cid Xutglá, et al. ²⁰ .	

ce generalmente tras la realización de una intervención vascular invasiva, cirugía vascular o más raramente, con el tratamiento anticoagulante oral, como heparina o fibrinolíticos. Además de púrpura, se observan úlceras o *livedo reticularis*¹. Debemos vigilar una posible insuficiencia renal como principal afectación sistémica.

Otras causas

Podemos observar púrpuras sistémicas no palpables ante situaciones puntuales que produzcan una elevación puntual de la presión venosa intravascular, como vómitos repetidos, parto, tos paroxística, llanto, maniobras de Valsalva, utilización repetida del esfigmomanómetro o prueba del torniquete².

B.) B. Púrpura palpable:

Las púrpuras palpables son siempre de causa sistémica. Según su etiología se clasifican en:

B.1) Causas embólicas: aparecen en situaciones que suponen una urgencia hospitalaria, principalmente asociadas a la

meningococemia aguda, la gonococia diseminada, la fiebre manchada por *Rickettsia* y la ectima gangrenosa. Requieren un abordaje precoz. Además, se acompañan generalmente de afectación grave del estado general.

B.2) Vasculitis: se clasifican en función del tamaño del vaso y de la etiología (tablas 2 y 3); sin embargo, ocasionalmente son idiopáticas, pudiendo un único agente causal dar numerosas manifestaciones clínicas¹⁹. Las manifestaciones clínicas varían según la localización y tamaño de los vasos afectados, aunque encontramos manifestaciones comunes como fiebre, pérdida de peso, astenia, malestar general, artralgias o artritis. En la tabla 2 se relacionan características clínicas típicas con la localización de los vasos.

La clasificación de las vasculitis según el tamaño del vaso y la etiología se recoge en la tabla 3.

Vasculitis leucocitoclástica: púrpura de Schönlein-Henoch

La causa más frecuente de púrpura palpable es la vasculitis de pequeño vaso, también denominada vasculitis leucocitoclástica. Esta vasculitis está mediada principalmente por reacción de hipersensibilidad a fármacos, agentes infecciosos, enfermedades autoinmunes o neoplasias²¹.

La manifestación más común en nuestras consultas es la púrpura de Schönlein-Henoch, mediada por inmunoglobulina A (IgA). La forma más frecuente de presentación suele darse en niños menores de 10 años, aunque puede manifestarse de forma atípica en adultos. Se observa mayor incidencia en los meses de invierno. En niños se ha relacionado principalmente con *Streptococcus* beta hemolítico del grupo A, aunque también con otros agentes como parvovirus, virus de la hepatitis B y C, adenovirus, *Staphylococcus aureus*, *Mycoplasma* spp, vacunas y picaduras de insectos^{21,22}.

En la mayoría de las ocasiones la púrpura se localiza en extremidades inferiores, acompañándose de dolor abdomi-

TABLA 3. Clasificación de las vasculitis según el tamaño del vaso y la etiología

	Primarias	Secundarias
Vasculitis de gran vaso	• Arteritis de Takayasu • Arteritis de células gigantes	• Aortitis secundaria a artritis reumatoide, infección por tuberculosis o sífilis
Vasculitis de vaso mediano	• Poliarteritis nudosa • Enfermedad de Kawasaki	• Poliarteritis nudosa asociada a hepatitis B
Vasculitis de mediano y pequeño vaso	• Granulomatosis de Wegener • Enfermedad de Churg-Strauss • Poliangeitis microscópica	• Artritis reumatoide • Lupus eritematoso sistémico • Síndrome de Sjögren • Fármacos • Infección por VIH
Vasculitis de pequeño vaso	• Púrpura de Schönlein-Henoch • Crioglobulinemia mixta esencial	• Fármacos • Infecciones • Crioglobulinemia asociada a virus hepatitis C
Modificada de Cid Xutglá, et al. ²⁰ .		

nal, artralgias y daño renal como principales manifestaciones. La confirmación del diagnóstico deberá hacerse mediante la realización de una biopsia, que muestra los depósitos de IgA²².

La morbilidad de esta entidad está relacionada con la enfermedad renal, por lo que debemos indagar sobre la posible existencia de lesión orgánica.

Claves para el diagnóstico

Ante la presencia de púrpura en atención primaria, debemos realizar primeramente una anamnesis completa y una adecuada exploración física. En la tabla 4 se recogen los elementos a incluir en la anamnesis.

Tras la anamnesis, debemos continuar con la exploración física completa y adecuada, donde se incluyan los elementos recogidos en la tabla 5.

Una vez realizada la anamnesis y la exploración física, debemos continuar realizando una valoración de la lesión

TABLA 4 Elementos de la anamnesis que se deben recoger ante una lesión purpúrica
Anamnesis
Antecedentes familiares: enfermedades autoinmunes, hematológicas, historia de sangrado
Edad e inicio del cuadro
Clínica: • Historial de traumatismos de repetición o traumatismos en los que resulte difícil de controlar el sangrado • Epistaxis de repetición • Sangrados gastrointestinales • Menstruación abundante • Características del exantema: inicio, progresión, cronología de las lesiones, etc.
Datos a preguntar para orientar la causa: • Antecedentes de enfermedades infecciosas (víricas o bacterianas) • Contacto con personas con patología infecto-contagiosa • Picaduras • Viajes
Fármacos
Modificada de Fierro-Urturi ²³ .

TABLA 5. Elementos de la exploración física que se deben recoger ante una lesión purpúrica		
Exploración física		
Constantes vitales: temperatura, tensión arterial (en ambos miembros superiores si sospechamos vasculitis)	Palidez mucocutánea	Lesiones dérmicas
Presencia de adenopatías	Hepato o esplenomegalia	Afectación ósea o articular
Modificada de Fierro-Urturi ²³ .		

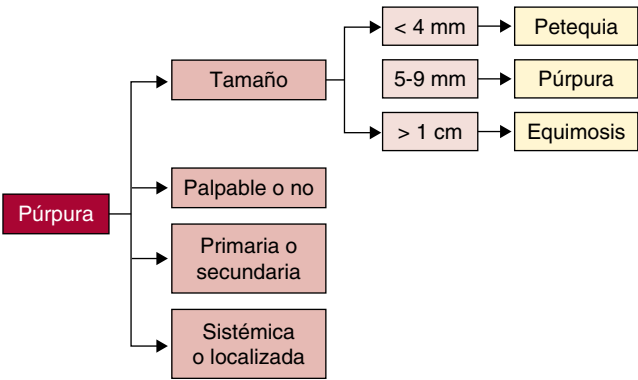


Figura 2. Algoritmo de clasificación en la exploración de las lesiones purpúricas. Elaboración propia.

purpúrica, ya que nos orientará hacia su causa, teniendo en cuenta las siguientes características de la lesión (fig. 2):

1. El tamaño de la lesión.

Es importante identificar el tamaño de la púrpura, ya que definirá la lesión. Llamaremos petequia a la lesión menor de < 4 mm; púrpura si su tamaño está comprendido entre 5-9 mm; o equimosis si es mayor de 1 cm².

2. Si es primaria o secundaria.

Debemos indagar sobre si la púrpura es primaria, es decir, ha aparecido espontáneamente, o si previamente había una lesión (celulitis, picaduras, eccemas, o traumatismos)²⁴. La púrpura primaria es más frecuente y debemos descartar manifestaciones extracutáneas.

3. Si es sistémica o localizada: dependiendo de la zona en la que aparezca la púrpura y su extensión.

4. Si es o no palpable.

Cuando la lesión purpúrica es palpable, indica que la extravasación de hematíes a la dermis se acompaña de inflamación de la pared vascular (vasculitis)².

En algunas ocasiones, tras la realización de dichas valoraciones, puede ser precisa la realización de pruebas complementarias. La mayor parte de las determinaciones complejas (como biopsia o tomografía axial computerizada) se deberán realizar en el entorno hospitalario, requiriendo derivación para estudio. Entre las pruebas complementarias que se pueden solicitar se encuentran:

Hemograma:

• Se debe incluir número de reticulocitos y perfil férrico (a señalar en la bioquímica) en caso de encontrar anemia.

• Si encontramos alguna alteración en serie roja, serie blanca o a nivel plaquetario, es recomendable solicitar un frotis sanguíneo.

• Si hay alteraciones plaquetarias, se debe solicitar al laboratorio: la fracción de plaquetas inmaduras (IPF), ya que se correlaciona directamente con la actividad megacariocítica. Si la producción se encuentra disminuida, el IPF será ba-

jo; en cambio, si hay un aumento de la destrucción plaquetaria, el IPF será alto²³.

- Coagulación:

Vía intrínseca: tiempo de tromboplastina activado (TTPA) o de cefalina.

Vía extrínseca: tiempo de protrombina o de Quick (TP o TQ) e INR.

- Evaluación de la formación y destrucción de fibrina: fibrinógeno y tiempo de trombina (TT). Explora la fase final de la coagulación. Se alarga cuando existen alteraciones del fibrinógeno, hiperfibrinólisis o tratamiento con heparina.

- Test de exploración de la hemostasia primaria: tiempo de hemorragia de Ivy, que es normal cuando es menor a 9 minutos. Su alargamiento es indicativo de una alteración plaquetaria (en número o en función), como una deficiencia del factor Von Willebrand o del fibrinógeno. También se altera por patología de la pared vascular.

- Velocidad de sedimentación globular (VSG).

El hemograma y la coagulación nos serán especialmente útiles cuando estemos ante una púrpura no palpable, en la que sospechemos alguna alteración a nivel de plaquetas o factores de la coagulación. Otras pruebas que también pueden tener utilidad son:

- Bioquímica general, incluyendo lactato deshidrogenasa, ácido úrico, perfil férrico (especialmente ante casos de anemia), proteína C reactiva (PCR), función tiroidea y transaminasas²³.

- Sedimento urinario, descartando hematuria y proteinuria principalmente.

- Serologías de virus de la hepatitis B (VHB), virus de la hepatitis C (VHC) y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

- Pruebas inmunológicas: si estamos ante una púrpura palpable y sospechamos la existencia de una vasculitis. Estas pruebas deben incluir como marcadores²³:

- Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA).
- Anticuerpos antineutrófilos (ANA).
- Factor reumatoide (FR).
- Anticuerpos antifosfolípidos.
- Crioglobulinas.

- Otras pruebas: se puede valorar en pacientes que no responden a tratamiento y sin una causa que justifica la clínica realizar test de embarazo en mujeres jóvenes de edad fértil, detección de *Helicobacter pylori* y marcadores de celiaquía (anticuerpos antitransglutaminasa)²³.

Pruebas de imagen:

- Radiografía de tórax: de forma inicial, si se sospecha, infección respiratoria, síndrome de vena cava superior o enfermedades sistémicas con afectación pulmonar.

- Tomografía axial computerizada (TAC) de tórax: se realizará en casos seleccionados, especialmente si tras haberse realizado una radiografía de tórax, es preciso completar el estudio.

- TAC cerebral: ante la presencia de clínica neurológica.

Biopsia: debe realizarse preferentemente en las primeras 48 horas con inmunofluorescencia en caso de sospecha de enfermedad sistémica o en casos de púrpura palpable²⁴. Se valorará realizar una biopsia renal, hepática o pulmonar en el medio hospitalario, en función del cuadro clínico del paciente.

Tratamiento

El tratamiento de la púrpura será el tratamiento específico de su etiología, si bien debemos tener en cuenta la prevención de hemorragias graves, en pacientes con alteraciones plaquetarias y de la coagulación. A continuación, se expone el tratamiento de las principales entidades descritas en el texto.

Púrpura trombocitopénica inmune

El tratamiento debe ser individualizado. Se tomará una actitud expectante en casos de sangrados leves, es decir, menos de 100 petequias, menos de 5 lesiones equimóticas o cuando no haya sangrado de mucosas²³. Por el contrario, si aparece hemorragia activa en mucosas o sospecha de hemorragias internas que afecten a la calidad de vida del paciente, se debe establecer un tratamiento activo.

Los corticoides a altas dosis o inmunoglobulinas intravenosas constituyen la primera línea de tratamiento. Se valorará la esplenectomía, como tratamiento de segunda línea, en casos de fracaso de tratamiento previo y cuando la hemorragia suponga un riesgo vital. En la tabla 6 se exponen las consideraciones que debe seguir el paciente esplenectomizado.

Hemofilia

El tratamiento con el derivado sintético de la hormona anti-diurética es el de elección en casos leves y moderados y no ocasiona efectos secundarios significativos. Se administra por vía intranasal. En las formas graves, el tratamiento de elección lo constituirán preparados de factor VIII²⁵.

Los antifibrinolíticos (como el ácido tranexámico) también pueden utilizarse como profilaxis o en el tratamiento de complicaciones hemorrágicas, especialmente en extracciones dentarias y gingivorragias²⁵.

TABLA 6. Consideraciones ante el paciente esplenectomizado

Vacunación frente a neumococo, meningococo y *Haemophilus influenzae* tipo B

Evitar viajar a zonas endémicas de paludismo

Administración de penicilina oral diaria o amoxicilina hasta un mínimo de 2 años tras la intervención

Modificada de Fierro-Urturi²³.

Coagulación intravascular diseminada

Constituye una emergencia vital, por lo que la actuación debe ser rápida y eficiente. En primer lugar, se debe identificar y tratar la causa y el shock producido. Además, se deben reponer los factores de la coagulación y las plaquetas posiblemente dañadas. En algunas ocasiones, se puede considerar administración de fibrinógeno en crioprecipitado o los concentrados de antitrombina III²⁶.

Púrpura trombocitopénica trombótica

El tratamiento principal es la plasmaféresis, aunque conjuntamente deben administrarse corticoides intravenosos (metilprednisolona o prednisolona). También contamos con el rituximab en casos de afectación cardíaca, neurológica en pacientes con VIH.

Trombocitopenia inducida por fármacos

El tratamiento consiste en la retirada del fármaco sospechoso. Se suele resolver, sin necesidad de otra intervención, en la primera semana tras suspender el medicamento, aunque con fármacos con semividas más largas, puede tardar más la resolución de la trombocitopenia¹⁵.

Arteritis de Takayasu

El tratamiento consiste en la administración de prednisona (60 mg/día) durante un mes con reducción progresiva. Sin embargo, tan solo el 20% de los pacientes mantienen la remisión, por lo que pueden añadirse inmunosupresores como metotrexato, azatioprina o micofenolato de mofetilo. En casos refractarios se puede administrar tocilizumab²⁰.

Arteritis de células grandes

El tratamiento con corticoides, además de producir una remisión rápida y completa, sirve también en la prevención de lesiones isquémicas. En casos de la arteritis de la temporal con pérdida de visión, se puede asociar al tratamiento con corticoides, ácido acetilsalicílico²⁰.

Poliarteritis nudosa (PAN)

La base del tratamiento son los corticoides hasta un máximo 60 mg/día de prednisona. En caso de reactivación, debe asociarse azatioprina; y en formas graves con afectación renal, neurológica, cardíaca o digestiva, el tratamiento debe ser conjunto con ciclofosfamida²⁰.

Enfermedad de Kawasaki

El tratamiento de esta entidad consiste en la administración de ácido acetilsalicílico y gammaglobulina intravenosa. Pero en casos en los que no se produzca respuesta al tratamiento, se pueden administrar pulsos de metilprednisolona o inmunosupresores, como ciclofosfamida o infliximab²⁰.

Vasculitis mediadas por IgA: (púrpura de Schönlein-Henoch)

En la mayoría de los casos, el tratamiento consiste en reposo y administración de antiinflamatorios no esteroideos en caso de artralgias. En los casos de afectación visceral, el tratamiento debe ser con prednisona.

Crioglobulinemia mixta

El tratamiento debe ser conservador ante casos leves. Cuando las lesiones son graves o existe afección visceral, se asocia rituximab. En los casos de crioglobulinemia mixta asociada al virus de la hepatitis C debe corregirse la infección por dicho virus²⁰.

Enfermedad de Churg-Strauss

También conocida como granulomatosis eosinofílica con poliangéitis. El tratamiento se realiza con glucocorticoides, siguiendo un descenso progresivo según la respuesta terapéutica. Este tratamiento debe mantenerse al menos durante un año a dosis bajas. Los inmunosupresores como azatioprina o metotrexato se añaden en casos de afectación cardíaca, neurológica o digestiva. Si la forma de presentación es grave, se realizarán pulsos de ciclofosfamida intravenosa. La terapia biológica con rituximab también ha resultado útil, así como el omalizumab y mepolizumab en el control de síntomas respiratorios y rinosinusales²⁰.

Enfermedad de Wegener

También conocida como granulomatosis con poliangéitis. El tratamiento se divide en una fase de inducción y otra de mantenimiento. Así, en las formas generalizadas o graves, se administrará glucocorticoides y ciclofosfamida en pulsos mensuales. También se puede utilizar rituximab. Una vez que se alcance la remisión, la ciclofosfamida se puede sustituir con azatioprina y debe mantenerse al menos 18 meses. Por otro lado, se aconseja la profilaxis con trimetoprim y sulfametoxazol tres veces/semana en todos los pacientes que reciban tratamiento con glucocorticoides y ciclofosfamida, ya que existe una alta prevalencia de infección por *Pneumocystis jirovecii* en caso de no administrarse²⁰.

Recomendaciones en el seguimiento

El papel del médico de familia es fundamental en el diagnóstico y seguimiento del paciente con púrpura. En primer lugar, es el principal responsable tanto del control de sintomatología del paciente como de los controles analíticos que este debe realizarse. Además de ello, la monitorización de posibles efectos secundarios del tratamiento es otro aspecto a reevaluar periódicamente. Tener en cuenta todos estos factores ayuda a mejorar la adherencia terapéutica, logrando

abordar eficientemente los posibles efectos secundarios que produzcan. Así, en pacientes con clínica hemorrágica, se debe instaurar el tratamiento con antifibrinolíticos cuando esté indicado⁶. También el médico de atención primaria debe orientar sobre los fármacos que están contraindicados ante numerosas situaciones clínicas. Por ejemplo, en pacientes con PTI, debemos evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos⁶. Por último, se deben conocer los criterios de derivación y gravedad¹⁴.

Criterios de derivación ante una púrpura

- Púrpura en la edad neonatal.
- Ante dudas diagnósticas o persistencia en el tiempo.
- Signos o síntomas de septicemia o infección grave.
- Signos o síntomas de afección extracutánea en púrpura palpable.
- Presencia de extensas áreas equimóticas en distintas regiones.
- Niveles disminuidos de plaquetas, especialmente < 20.000-30.000 plaquetas/mm³.
- Hemorragias o sangrados abundantes en mucosas.
- Signos directos de sangrado, como: hematuria, hematemesis, hemoptisis, etc.
- Signos indirectos derivados del sangrado, como: hipotensión, anemia, taquicardia, shock, etc.
- Púrpura acral acompañada de *livedo reticularis* tras el antecedente de un proceso invasivo intravascular (enfermedad por émbolos de colesterol).
- Derivación programada ante alta sospecha clínica o confirmación de patologías, como: PTI, trombocitosis, hemofilias, vasculitis cutánea de pequeño vaso, etc.
- Derivación urgente ante la sospecha clínica de patologías graves, como: CID, púrpura en el contexto de sepsis bacteriana, enfermedad por émbolos de colesterol, PTI con manifestaciones clínicas hemorrágicas, hemofilias con extensas hemorragias, vasculitis de pequeño vaso con afectación multiorgánica, septicemia e inestabilidad hemodinámica.

Bibliografía

- Casas-Rodríguez J, Sole-Sancho J. La púrpura en la visita de atención primaria. AMF. 2011;7(11):635-41.
- Bielsa-Marsol I. Manifestaciones dermatológicas de las enfermedades sistémicas. En: Farreras Rozman. Medicina Interna. 19ª Edición. 2020;165:1283-96.
- Abad A, Cermelj M, Scoles G. Trombocitopenia como factor de riesgo de morbi-mortalidad en los pacientes hospitalizados en una Unidad de Terapia Intensiva. Hematología. 2021;25(1):9-18.
- Monteagudo E, Astigarraga I, Cervera Á, Dasí MA, Sastre A, Berrueto R, et al. Protocolo de estudio y tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria: PTI-2018. An Pediatr (Engl Ed). 2019;91(2):127.e1-127.e10.
- Oñate I, Ortiz M, Suso A, Mon C, Galindo K, Lentisco C, et al. Vasculitis IgA con nefritis (púrpura de Schönlein-Henoch) tras COVID-19: una serie de casos y revisión de la literatura. Nefrología. 2022;42(4):481-9.
- Cervera-Bravo A, Muñoz Bermudo F. Púrpuras más frecuentes. Trombocitopenia inmune primaria y vasculitis por IgA (Púrpura de Schönlein-Henoch). Pediatr Integral. 2021;25(5):254-64.
- Fierro-Urturi A. Púrpuras, trombocitopenia inmune primaria. Pediatría Integral. 2016;26 (5):399-412.
- Goyal P, Dayal S, Sahu P. Generalized Livedo Reticularis: A Rare Variety. Indian J Dermatol. 2019;64(1):59-61.
- Menditto V, Borrelli L. Bateman's disease. Pathologica. 1994;86(6):645-8.
- Casanova-Seuma JM, Aguayo-Ortiz R, Ribera-Pibernat M. Patología dermatológica. En: Atención primaria. Problemas de salud en la consulta de medicina de familia. 8ª Edición. 2019;37:1015-55.
- Curtis BR. Drug-induced immune thrombocytopenia: incidence, clinical features, laboratory testing, and pathogenic mechanisms. Immunohematology. 2014;30(2):55-65.
- Danese E, Montagnana M, Favalaro EJ, Lippi G. Drug-Induced Thrombocytopenia: Mechanisms and Laboratory Diagnostics. Semin Thromb Hemost. 2020;46(3):264-74.
- Magro CM, Wang X. Cocaine-associated retiform purpura: a C5b-9-mediated microangiopathy syndrome associated with enhanced apoptosis and high levels of intercellular adhesion molecule-1 expression. Am J Dermatopathol. 2013;35(7):722-30.
- Carrascosa JM, Ferrándiz C. Púrpura. FMC. 2001;8(4):215-29.
- Abrams C. Trombocitopenia. En: Goldman-Cecil. Tratado de medicina interna. 26ª Edición. 2021;163:1125-34.
- Kremer-Hovinga JA, Coppo P, Lämmle B, Moake JL, Miyata T, Vanhoorelbeke K. Thrombotic thrombocytopenic purpura. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17020.
- Mingot-Castellano ME, Pascual-Izquierdo C, González A, Viejo-Llorente A, Valcarcel-Ferreiras D, Sebastián E, et al. Recommendations for the diagnosis and treatment of patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. Med Clin (Barc). 2022;158(12): 630.e1-630.e14.
- Kurt M, Shorbagi A, Aksu S, Haznedaroglu I, Altundag K, Erkin G. Warfarin-induced skin necrosis and leukocytoclastic vasculitis in a patient with acquired protein C and protein S deficiency. Blood Coagul Fibrinolysis. 2007;18(8):805-6.
- Carlson JA, Ng BT, Chen KR. Cutaneous vasculitis update: diagnostic criteria, classification, epidemiology, etiology, pathogenesis, evaluation and prognosis. Am J Dermatopathol. 2005;27(6):504-28.
- Cid-Xutglá MC, Solans Laqué R, Hernández Rodríguez J, Cervera Segura R, Selva O'Callaghan A, Pons-Estel GJ, et al. Vasculitis. En: Farreras Rozman. Medicina Interna. 19ª Edición. 2020;135:1057-72.
- Borlán-Fernández S. Vasculitis por IgA (púrpura de Schönlein-Henoch). Protoc Diagn Ter Pediatr. 2020;2:225-38.
- Koutkia P, Mylonakis E, Rounds S, Erickson A. Leucocytoclastic vasculitis: an update for the clinician. Scand J Rheumatol. 2001;30(6):315-22.
- Fierro-Urturi A. Púrpuras. Trombocitopenia inmune primaria. Pediatr Integral. 2016;20(5):331-45.
- Cobo T, Muñoz F. Vasculitis leucocitoclástica. Fistera. 2014 [consultado 7 Jul 2023]. Disponible en: <https://www.fistera.com/guias-clinicas/vasculitis-leucocitoclastica/>
- Ragni M. Trastornos hemorrágicos: deficiencias de factores de la coagulación. En: Goldman-Cecil. Tratado de medicina interna. 26ª Edición. 2021;165:1140-8.
- Schafer A. Trastornos hemorrágicos: coagulación intravascular diseminada, insuficiencia hepática y deficiencia de vitamina K. En: Goldman-Cecil. Tratado de medicina interna. 26ª Edición. 2021;166:1149-52.